

République Algérienne démocratique et populaire

Université de Constantine 3

Faculté de médecine

***Reflux Gastro-Oesophagien et ses complications:
diagnostic et traitement***

Dr Kassama

Service d'Hépatogastroentérologie et d'endoscopie digestive

CHU de Constantine

Année universitaire: 2016-2017

I-Définition :

le reflux permanent ou intermittent du contenu gastrique vers l'oesophage à travers le hiatus œsophagien: Passage d'une partie du contenu gastrique dans l'œsophage.

RGO physiologique: présent chez tous les sujets, bref, post-prandial ++, et qui, par définition, ne s'accompagne ni de symptôme ni de lésion muqueuse œsophagienne.

II. Épidémiologie :

Le reflux gastroœsophagien pathologique représente une des affections digestives les plus fréquentes;

Affection bénigne, CPC possibles

La prévalence du RGO est élevée et en augmentation régulière dans les pays occidentaux.

-30 à 45 % épisode mensuel

- 5 à 25 % épisode par semaine

-5 à 10 % épisode journalier

III-Physiopathologie : Multifactorielle.

- Les anomalies de la jonction oeso-gastrique
- La toxicité des produits endogènes
- L'altération des mécanismes de défense
- L'altération de la clearance œsophagienne
- Les anomalies de la motricité gastrique

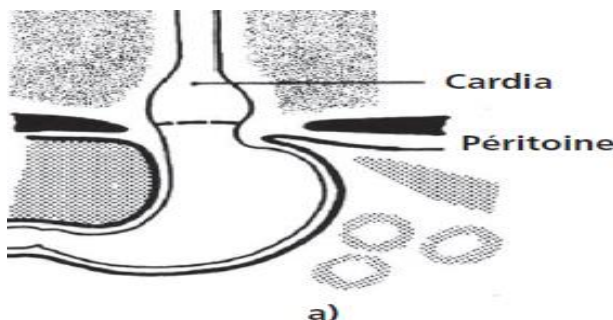
1-Les anomalies de la jonction oeso-gastrique: Élément clé

-Fonctionnelles : La physiopathologie du RGO fait principalement intervenir la défaillance du

SIO. Le SIO est une zone de haute pression qui s'oppose au gradient de pression abdomino-thoracique

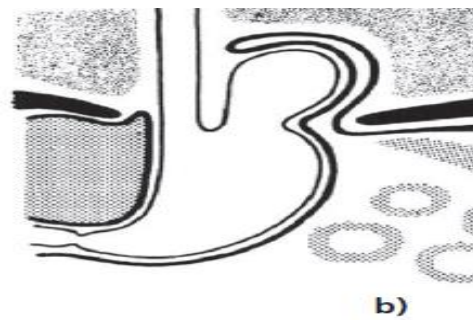
Les épisodes de RGO s'observent surtout lors des relaxations transitoires spontanées du SIO.

- Anatomiques (l'existence d'une hernie hiatale)



Hernie par glissement

elle n'est ni nécessaire, ni suffisante pour expliquer un RGO : le RGO peut exister sans hernie hiatale et une hernie hiatale peut ne pas être associée à un RGO.



Hernie par roulement

n'a pas de lien avec le RGO.

2-La toxicité des produits endogènes:

_concentration en ions H⁺ et en pepsine (en cas de reflux duodénogastrique): l'effet néfaste dépend de la concentration et de la durée d'exposition de la muqueuse oesophagienne

Le reflux alcalin et biliaire est très agressif et peu fréquent.

3-L'altération des mécanismes de défense:

la perméabilité muqueuse oesophagienne

Relâchement du corps de l'œsophage

4-L'altération de la clearance oesophagienne:

Le couple "péristaltisme oesophagien / salive" peut être altéré en période nocturne ou chez les sujets âgés en raison de la diminution de la motricité oesophagienne et de la sécrétion salivaire.

5-Les anomalies de la motricité gastrique:

Vidange gastrique ralentie et la stase gastrique.

Etiologies non sphinctériennes:

- Gastrectomie polaire supérieure ou toute autre intervention chirurgicale pouvant affaiblir ou supprimer la barrière anti-reflux (intervention de Heller)

-Hyperpression abdominale (surcharge pondérale, prise récente de poids, efforts de toux).

- La présence prolongée d'une sonde gastrique

- La grossesse, environ la moitié des femmes enceintes présentent un pyrosis ou des régurgitations, souvent T3. Des facteurs mécaniques (hyperpression intra-abdominale), la progestérone ++

- L'atteinte oesophagienne au cours de la **sclérodermie est fréquente**

des facteurs favorisant le RGO :

-Alcool, graisses, chocolat, café , l'obésité et le tabagisme.

-médicaments : la théophylline, les anticholinergiques, les dérivés nitrés, les antagonistes calciques, les AINS, la progestérone...

IV-Etude clinique :

1- **Symptômes typiques** : spécifiques, peuvent suffire à affirmer le diagnostic

o Pyrosis (brûlure rétrosternale et ascendante à point de départ épigastrique) postprandial,

o Régurgitations (liquides ou alimentaires)

Le caractère postural et/ou post-prandial de ses signes est un élément supplémentaire très évocateur.

2-Symptômes atypiques: La responsabilité du RGO est impliquée dans des manifestations extradigestives, qui sont moins spécifiques :

o Digestifs (brûlures épigastriques)

o Douleurs thoraciques qui peuvent simuler un angor et nécessiter un bilan cardiologique qui reste négatif

o Respiratoires: dyspnée asthmatiforme, toux chronique

o Manifestations ORL (enrouement souvent au réveil, laryngite chronique, fausses angines)

o Erosions dentaires, gingivites ou caries dentaires à répétition

Il faut donc savoir évoquer le RGO lorsqu'un bilan pulmonaire, ORL ou cardiaque approfondi est normal. Néanmoins, établir un lien causal entre le RGO et ces manifestations atypiques est difficile.

Symptômes d'alarme:

- Dysphagie
- Hématémèse
- Amaigrissement
- Anémie

V-Approche diagnostique :

1-Diagnostic clinique ++

Avant 50 ans, dans la forme typique: les symptômes typiques sont très spécifiques.

Pas d'examen complémentaire, Test aux IPP.

2-Endoscopie oesogastro duodénale

- o en première intention si :

-Présence de signes d'alarme +++

-Âge > 50 ans

- Résistance au traitement initial ou rechute précoce à l'arrêt du traitement

-Symptômes atypiques isolés

- o BUT:

-Permet d'affirmer le diagnostic de RGO en cas de découverte d'une œsophagite ulcérée, dépiste les complications ou lésions pré-cancéreuses (sténose, muqueuse de Barrett).

- Biopsies œsophagiennes étagées systématiques (minimum 5) si dysphagie associée et aspect endoscopique normal ou évocateur d'œsophagite à éosinophiles ou de RGO résistant aux IPP.

-Normale dans plus de 50 % des cas

- Recherche de complications

-Recherche d'oesophagite : selon la **Classification de Los Angeles**

Grade A : une ou plusieurs lésions muqueuses (perte de substance) de moins de 5 mm

Grade B : une ou plusieurs lésions muqueuses (perte de substance) de plus de 5 mm, ne s'étendant pas entre les sommets de deux plis muqueux adjacents

Grade C : une ou plusieurs lésions muqueuses se prolongeant en continuité entre les sommets de 2 ou plusieurs plis muqueux, mais qui occupent moins de 75% de la circonférence

Grade D : une ou plusieurs lésions muqueuses occupant plus de 75% de la circonférence

3-pH métrie œsophagienne : Sensible pour diagnostiquer un RGO pathologique ; Consiste à analyser les variations du pH œsophagien pendant 24 heures au moyen d'un capteur intraoesophagien, mise en place d'une sonde à 5cm du cardia, reliée à un boîtier indicateur d'évènement, doit être réalisée après un arrêt de 10 jours des IPP

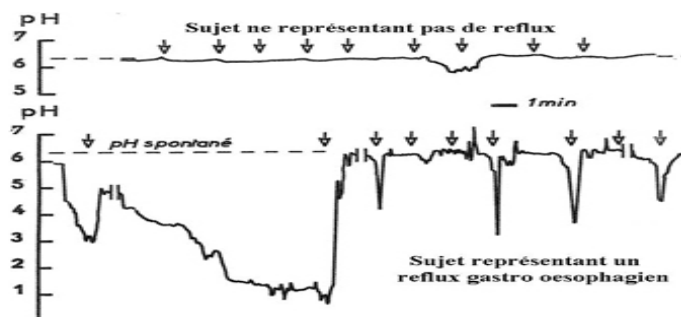
Mesure sur 24h de l'exposition acide de l'œsophage avec analyse de la relation entre symptômes et reflux (symptômes 2 minutes après le reflux)

Reflux acide pathologique (exposition acide > 5% du temps)

Indications:

- Symptômes atypiques isolés
- Bilan préopératoire en l'absence de RGO documenté

Avec endoscopie oeso-gastroduodénale normale



La pH métrie sans fil de 48h : Capsule fixée à l'œsophage, au cours d'une endoscopie digestive, les données sont transmises par télémetrie à un boîtier externe d'enregistrement

Avantages : meilleur tolérance, pas d'inconfort nasal

4-Autres explorations:

pH impédancemétrie œsophagienne

le seul examen permettant de mettre en évidence un RGO peu ou non acide. Cet examen est surtout indiqué pour rechercher un reflux persistant sous traitement anti-sécrétoire.

Manométrie œsophagienne

- Bilan préopératoire (hautement recommandé)
- Suspicion de troubles moteurs œsophagiens sévères
- En cas de dysphagie associée, si gastroscopie normale

Transit oeso-gastro-duodénal : n'a pas d'intérêt pour le diagnostic du RGO

- Bilan pré-opératoire (indication possible si volumineuse hernie hiatale)

- Eventuellement en cas de sténose

Le test aux IPP

Non recommandé (médiocre spécificité pour le diagnostic de RGO)

VI-Complications :

- Sténose peptique

- Ulcère de l'oesophage : associé dans 20 % des cas à la sténose peptique
siège le plus souvent en muqueuse d'EBO

- Hémorragie digestive : 5% (AINS, âge, alcool, tares)

- Endobrachy-oesophage : ou oesophage de Barrett, est défini par le remplacement de l'épithélium normal malpighien de l'oesophage distal par un épithélium métaplasique cylindrique de type intestinal

la mise en évidence d'une métaplasie intestinale impose de proposer au malade une surveillance régulière avec des biopsies étagées multiples pour dépister l'apparition d'une dysplasie, étape préalable au cancer invasif.

- Adénocarcinome de l'oesophage : de pronostic très sombre.

VII. Traitement :

Les objectifs thérapeutiques :

- Le soulagement des symptômes, amélioration de la qualité de vie,

- La cicatrisation des lésions en cas d'oesophagite

- La prévention des récurrences

1-Règles hygiéno-diététiques : peu efficaces

- Surélévation de 45° de la tête du lit ;

- Coucher à distance du repas (l'augmentation au-delà de 3h de l'intervalle « diner-coucher »)

- Réduction pondérale

- Vêtements peu serrés

- Réduction de la consommation du tabac ou d'alcool

2-Traitement médicamenteux

- Antiacide et alginate : à la demande, ils permettent une amélioration des symptômes mais ne permettent pas la cicatrisation des lésions muqueuses.

- Antagoniste des récepteur H2 de l'Histamine

Efficaces sur les symptômes et sur les lésions d'oesophagite (cicatrisation de 50% à 6 semaines)

Pas d'efficacité dans la prévention des récurrences

- Les inhibiteurs de la pompe à protons: Traitement de référence

Les IPP sont supérieurs aux anti-H2 en termes de cicatrisation muqueuse et de soulagement symptomatique.

La tolérance des IPP est excellente.

Les effets secondaires les plus fréquents sont la diarrhée et les céphalées (<10% des patients).

3-La chirurgie:

Fundoplicature par laparoscopie : totale de Nissen valve de 360°, ou partielle postérieure 180 ou 270° (Toupet)

Indications :

- Régurgitation malgré le traitement médical (après manométrie et impédancemétrie)
- Patients "IPP dépendants" ne souhaitant pas prendre de traitement au long cours

Efficacité de 70 à 90 % des cas

4-Stratégie thérapeutique

1-Symptômes typiques peu invalidants et/ou très intermittents, âge < 50 ans et absence de signes d'alarmes :

Règles hygiéno-diététiques

Alginates/anti-acides

Cure courte d'anti-H2 ou d'IPP à demi-doses (3-4 semaines)

2-Age > 50 ans, ou signes d'alarme, ou résistance d'emblée ou rechute rapide à l'arrêt du traitement initial :

Endoscopie ++ pour éliminer des complications (muqueuse de Barrett, sténose peptique, cancer) et biopsies oesophagiennes étagées si dysphagie associée (recherche d'oesophagite à éosinophiles)

En cas d'oesophagite non sévère: IPP simple dose pdt 4 sem. Si sévère: simple dose pdt 8 sem ,Si non cicatrisation doubler la dose

3-Symptômes atypiques isolés

Endoscopie (oesophagite: IPP double dose pdt 4-8 sem)

Si normale : pHmétrie sans traitement

4-Complications :

-Sténose peptique : doit être traitée en continu par des IPP à pleine dose, avec des dilatations endoscopiques en cas de dysphagie.

-Endobrachyoesophage : Seul l'EBO symptomatique ou associé à une oesophagite doit être traité par

IPP

4-Fundoplicature chirurgicale :

-les malades "IPP dépendants" et ne voulant pas de traitement au long cours

- les malades gardant des régurgitations gênantes sous traitement (après manométrie oesophagienne et pH-impédancemétrie).

